

Najczęstsze *obszary* zaabsorbowania

Większość osób z BDD koncentruje się na konkretnych częściach ciała w specyficzny sposób. Karta opisuje 6 najczęstszych obszarów, średnią liczbę obszarów na osobę i podtyp BDD mięśniowy u mężczyzn.

CZAS: 15 min — przeczytanie **Psychoedukacja** **ŹRÓDŁO:** Phillips i wsp. (2005); Pope i wsp. (1997)

JAK UŻYWAĆ

BDD nie jest niezadowolaniem z całego wyglądu — to **uporczywe zaabsorbowanie konkretnymi częściami ciała**. Phillips (2005) w badaniu 200 pacjentów ustaliła statystyczny obraz: skóra (73%), włosy (56%), nos (37%), masa ciała (22%), piersi/klatka (21%), oczy (20%), uda (20%), zęby (20%). Większość pacjentów ma **5-7 obszarów jednocześnie**, średnio 5,6. **Mężczyźni:** częściej genitalia, budowa mięśniowa (*muscle dysmorphia*), łysienie. **Kobiety:** skóra, masa ciała, piersi, biodra. Obszary *migrują* w czasie — gdy uda się rozwiązać jedno, zaabsorbowanie „przeskakuje” na inne.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Phillips i wsp. (2005): *średnia liczba obszarów ciała będących celem zaabsorbowania w BDD wynosi 5,6 — to nie „jedna wada”, to wzorec myślenia o ciele jako sumie defektów*. Konsekwencje praktyczne: **1)** rozpoznanie wzorca = pierwszy krok — obsesja na 5+ obszarach to BDD, nie pojedyncza wada; **2)** terapia BDD *nie* może skupiać się na jednym obszarze — musi adresować cały wzorec; **3)** *muscle dysmorphia* (zaburzenie mięśniowe, Pope 1997) jest często niediagnozowane, mylone z dążeniem do fitnessu; **4)** chirurgia rozwiązuje obszar #1, ale „budzi” obszar #2; **5)** klucz to praca z *uwagą wybiórczą i interpretacją*, nie z wyglądem.

01 = Sześć najczęstszych obszarów

1 · SKÓRA (73%)

Trądzik, blizny, asymetria, pory, zaczerwienienia. Najczęstszy obszar. Wielogodzinne sprawdzanie w lustrze, dotykanie, „poprawianie”.

2 · WŁOSY (56%)

Przerzedzenie, łysienie, asymetria fryzury, kolor, „nie tak jak powinny”. Mężczyźni częściej obsesyjnie monitorują linię włosów.

3 · NOS (37%)

Kształt, rozmiar, wielkość względem twarzy. Częsta motywacja do chirurgii estetycznej (rinoplastyka), która zwykle *nie* rozwiązuje problemu.

4 · MASA CIAŁA / SYLWETKA (22%)

Może wyglądać jak zaburzenie odżywiania, ale w BDD chodzi o *postrzeganie sylwetki*, nie o jedzenie. Odróżnić od anoreksji. U mężczyzn często *muscle dysmorphia*.

02 ● Muscle dysmorphia — podtyp u mężczyzn

Zaburzenie mięśniowe (ang. *muscle dysmorphia*, Pope 1997) — podtyp BDD, w którym osoba (najczęściej mężczyzna) jest **uporczywie przekonana, że jej ciało jest zbyt szczupłe lub niewystarczająco umięśnione**, mimo że obiektywnie jest dobrze zbudowana lub muskularna.

Typowe zachowania: wielogodzinne treningi siłowe (mimo kontuzji, zmęczenia), obsesyjna kontrola diety i suplementacji, mierzenie obwodów mięśni, używanie sterydów anabolicznych, unikanie sytuacji bez koszulki (basen, plaża, intymność), porównywanie z fotografiami modeli.

Dlaczego nieraz przegapione: wygląda jak „kult fitness” lub „dążenie do zdrowia”. Klucz: *dystres i upośledzenie funkcjonowania*. Człowiek z *muscle dysmorphia* *cierpi*, jego życie jest zorganizowane wokół ciała — to *nie* jest pasja sportowa.

Ryzyka: sterydy anaboliczne (uszkodzenia narządów, depresja, agresja), kontuzje treningowe, izolacja społeczna, depresja, myśli samobójcze.

Kluczowa obserwacja kliniczna: w BDD zaabsorbowanie często *nie* dotyczy stałej „wady”. Gdy jeden obszar zostanie „rozwiązany” (chirurgicznie, dermatologicznie, treningiem) — uwaga *migruje* na inny.

Przykład sekwencji:

- Etap 1: obsesja na nosie → rinoplastyka → krótkotrwała ulga
- Etap 2: po 3–6 miesiącach uwaga przenosi się na skórę → konsultacje dermatologiczne
- Etap 3: po pewnym czasie — masa ciała → diety, treningi
- Etap 4: kolejna część...

Mechanizm: problem *nie* jest w wyglądzie, ale w *sposobie patrzenia i interpretowania*. Mózg z BDD *znajduje* defekt, bo szuka. Phillips: „chirurgia naprawia nos, ale nie naprawia uwagi wybiórczej, perfekcjonizmu ani wewnętrznych standardów”.

Wniosek: celem terapii BDD *nie* jest „rozwiązanie wady” — jest zmiana *relacji z ciałem i uwagi wybiórczej*. Bez tej zmiany każda interwencja kosmetyczna jest tymczasowa.

1. Wymień wszystkie części ciała, którymi się obecnie zaabsorbujesz:

2. Ile godzin dziennie poświęcasz myślom o tych obszarach? (zazwyczaj 3–8h w BDD)

____ godzin / dzień

3. Czy w przeszłości miałeś/-aś obsesje na innych obszarach, które się „uspokoili”?

4. Jakie zachowania powtarzające się stosujesz?

- ☐ Sprawdzanie w lustrze
- ☐ Kamuflaż (makijaż, ubrania, fryzura)
- ☐ Porównywanie się
- ☐ Pytanie o zapewnienie („czy widać?”)
- ☐ Unikanie luster / zdjęć
- ☐ Konsultacje kosmetyczne / chirurgiczne
- ☐ Inne: _____

Klucz: Phillips (2005): „BDD to nie jeden defekt — to wzorzec myślenia o ciele jako sumie wad. Mózg szuka i znajduje. Klucz nie tkwi w korekcie wyglądu, ale w zmianie sposobu patrzenia”. Twoje ciało nie wymaga naprawy — wymaga innego rodzaju uwagi.